INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP 04- ENDOSCOPIA-Página 1 de 5	
Título do Documento	ORIENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA	Emissão: 30/06/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 30/06/27

1. CONCEITO:

1.1 Responsáveis pela execução

Técnico de enfermagem, Enfermeiros e médico

1.2 Finalidades

- Prestar assistência adequada aos procedimentos de Endoscopia.

1.3 Indicações

È indicada para investigar a existência e/ou o estágio de doenças como gastrite, úlcera gástrica ou duodenal, doença do refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, pólipos ou tumores benignos, doença celíaca (intolerância ao glúten), infecções (por H. pylori, por exemplo), e cânceres.

1.4 Contra Indicação

Não há contraindicações absolutas, porém, cuidados especiais devem ser tomados no caso de pacientes cardiopatas graves, com doenças pulmonares graves, neurológicas e em mulheres grávidas.

2. MATERIAIS

- Endoscópio montado;
- Garrafa com água;
- Frasco de água para injeção de 500ml;
- Gaze;
- Cuba redonda pequena com água;
- Bocal com gaze;
- Seringa de 20ml;
- Frascos de formol para biópsia;
- Xilocaína gel;
- Xilocaína Spray;
- Frasco de dimeticona gotas;
- Agulha de aspiração;
- Pinças de biópsia gástrica;
- Cuba média com detergente enzimático diluído em água;
- Frasco de aspiração de 5000ml.

Outros materiais:

- Pinça dente de rato;
- Pinça boca de jacaré;
- Pinça dente de rato com boca de jacaré;
- Pinça duplo canal;
- Pinça infantil;
- Pinça para macrobiópsia;
- Fio guia para colangio (hidrofílico);
- Escova citológica endoscópica;

- Corantes: Indígo Carmin, Tiossufito e Azul de Metileno;
- Caps para pontas de endoscópios;
- Irrigadores descartáveis para acoplar no Kit ligadura;
- Botões de comandos dos endoscópios (sobressalentes);
- Caixa Kit endoscopia/ colonoscopia
- Caixa de materiais para procedimento
- Computador para laudos.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Recepcionar o usuário;
- Conferir identificação do usuário com o pedido do exame;
- Confirmar a retirada de próteses, óculos, bonés e adornos;
- Posicionar o usuário, mantendo-o aquecido e confortável para prevenção de úlcera de córnea e lesões de MMII/MMSS;
- Monitorar paciente (FC e oximetria de pulso);
- Instilar xilocaína spray, 3 borrifadas em cada lado da cavidade oral e solicitar deglutição;
- Inspecionar permeabilidade do acesso venoso;
- Instalar e controlar oxigenoterapia se necessário;
- Colocar o bocal;
- Administrar sedativos conforme prescrição médica;
- Avaliar nível de consciência;
- Realizar manobras de abertura de vias aéreas/aspiração de secreções se necessário;
- Auxiliar nos procedimentos médicos;
- Identificar amostras coletadas para exames, protocolar e encaminhar ao destino adequado;
- Proceder os registros de enfermagem;
- Transportar usuário para sala de recuperação;
- Dar o destino adequado à instrumentos e materiais.

Cuidados de enfermagem

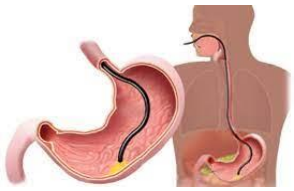
- Checar a solicitação medica e material para o procedimento incluindo material especial e checar equipamentos
- Ver com a farmácia se o material esta disponível
- Pedir para o paciente trocar de roupa e retirar adornos
- Tranqüilizar e orientar o paciente a respeito do exame
- Realizar admissão de enfermagem e check list de procediemtno seguro
- Realizar punção periférica, monitorizarão e posicionar o paciente
- Auxiliar o medico durante o procedimento
- Identificar e protocolar os materiais coletados
- Encaminhar o paciente para URPA após termino de exames, realizar motorização
- Checar identificação dos dispositivos, quantidade segura da solução

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

- Pelo menos 6 a 8 horas de jejum antes da endoscopia para assegurar que o estômago esteja vazio (pode ingerir água ou chá até 2 horas antes do exame);
- Informar o médico Gastrenterologista que lhe vai realizar o exame de toda a medicação que está a tomar, especialmente anticoagulantes (varfarina, acenocumarol, dabigatrano, rivaroxabano,...) ou antiagregantes plaquetares (ácido acetilsalicílico, ticlopidina, clopidogrel, ticagrelor, triflusal, dipiridamol,...); a suspensão ou não dos mesmos depende das suas doenças cardiovasculares e do risco de hemorragia do procedimento a que vai ser submetido, pelo que essa decisão compete ao seu Médico Assistente;
- Planear o dia do exame – nos casos de endoscopia com sedação, o doente não pode conduzir, trabalhar ou tomar decisões importantes após o exame, devendo permanecer acompanhado.
- NÃO ingerir bebidas que contenham álcool por pelo menos 12 horas após o exame

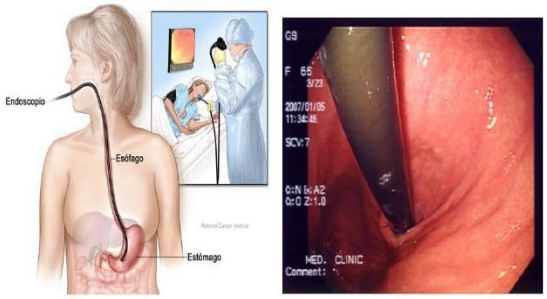
5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS

IMAGEM 01



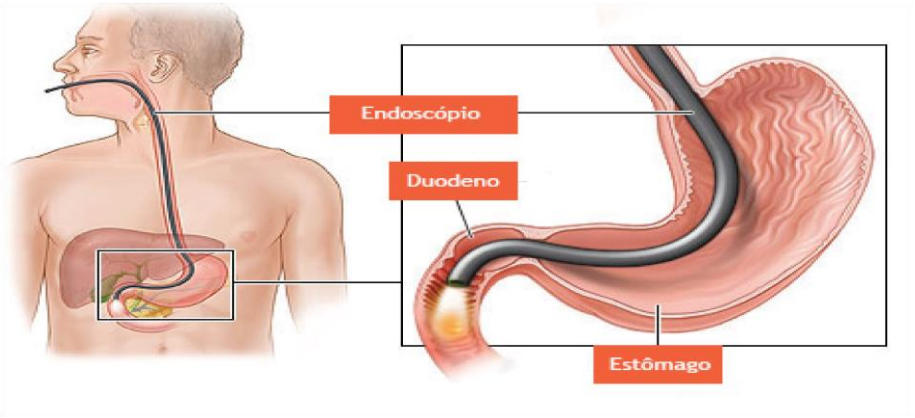
Google imagens

IMAGEM 02.



Google imagens

IMAGEM 03.



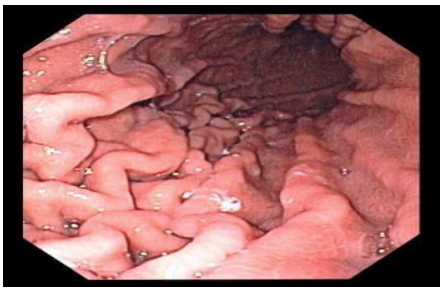
Google imagens

IMAGEM 04.



Google imagens

IMAGEM 05.



Google imagens

6. REFERÊNCIAS

1. QUINTERO, Rocío Pérez et al. Utilidad de la endoscopia intraoperatoria en cirugía esofagogástrica. **Cirugía Española**, 2023.

2. de Soares Veloso, J. C., & de Meneses, J. (Eds.). (2023). *Desafios em Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva*. Thieme Revinter.

3. SILVA, Milena Arão da et al. PREVALÊNCIA DE OBESIDADE EM PACIENTES DISPÉPTICOS ATENDIDOS EM UM SERVIÇO PÚBLICO DE ENDOSCOPIA EM IMPERATRIZ-MA. **O CUIDADO EM SAÚDE BASEADO EM EVIDÊNCIAS**, v. 1, n. 1, p. 217-227, 2023.

4. FARIAS, Genifer Amélia Dias; DE MENEZES SILVA, Rafaela; DE FREITAS, Rosa Caroline Mata Verçosa. Conhecimento de enfermagem frente as complicações de exames endoscópicos. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 6, n. 13, p. 648-658, 2023.

7. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/08/22	Elaboração inicial do documento
2	01/08/23	Alteração na formatação do documento
3	30/06/25	Alteração na formatação do documento

Versão 1 – Elaboração Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF	Data: 01/08/22
Versão 2 – Revisão Giulianna Carla Marçal Lourenço Gerente de Enfermagem COREN 315611-ENF **Validação** Nayanne Ingrid F.M. Guerra CCIH/NSP COREN 489616-ENF **Registro, análise e revisão final** Claudio Emananuel Gonçalves Filho Diretor Técnico **Aprovação** Sônia da Silva Delgado Diretora Assistencial	Data: 30/06/25